BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Kanser Taramaları Çalışma Notu

Meme · Serviks (Rahim Ağzı) · Kolorektal · KKMM · HPV-Smear · Gaitada Gizli Kan Testi · Tarama Eğitimi

Tarama programının mantığı, kimin ne zaman taranacağı, testlerin adım adım uygulanması ve kişiye anlatılması, sonuçların anlamı, pozitif sonuçta yapılacaklar ve kanser tarama eğitiminin planlanması.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Kanser Taramaları Çalışma Notu

1. Temel kavramlar

- 1.1 Tarama nedir?
- 1.2 Neden her kanser için tarama yok?
- 1.3 Bir tarama testinin sonucu nasıl anlaşılmalı?

2. Türkiye'de kanser tarama programı

- 2.1 Ulusal tarama standartları (ezberlenecek)
- 2.2 Hizmet nerede ve nasıl verilir?
- 2.3 Kanser taramasında ASM hemşiresinin görevleri
- 2.4 ASM'ye gelen bir kişinin tarama durumunu sorgulama

3. MEME KANSERİ VE TARAMASI

- 3.1 Bilmen gerekenler
- 3.2 Risk faktörleri – neden risk oluştururlar?
- 3.3 Meme kanserinin uyarı belirtileri
- 3.4 Kendi kendine meme muayenesi (KKMM)
- 3.5 Klinik meme muayenesi (KMM)
- 3.6 Mamografi

4. SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ VE TARAMASI

- 4.1 Bilmen gerekenler – HPV ile ilişki
- 4.2 Risk faktörleri
- 4.3 Uyarı belirtileri
- 4.4 Korunma
- 4.5 Tarama testleri
- 4.6 HPV-smear öncesi kadına verilecek hazırlık talimatı
- 4.7 Örnek alma işlemi ve hemşirenin rolü
- 4.8 Sonuçlar ne anlama gelir ve ne yapılır?

5. KOLOREKTAL (KALIN BAĞIRSAK) KANSERİ VE TARAMASI

- 5.1 Bilmen gerekenler
- 5.2 Risk faktörleri
- 5.3 Uyarı belirtileri
- 5.4 Gaitada gizli kan testi (GGT)
- 5.5 Sonuçlar ve sonrası

6. DİĞER KANSERLERDE ERKEN TANI VE FARKINDALIK

- 6.1 Kanserin genel uyarı işaretleri (eğitimde kullan)
- 6.2 Avrupa Kanserle Mücadele Kodu – 12 öneri (birincil korunma)

7. KANSER TARAMA EĞİTİMİ NASIL YAPILIR?

- 7.1 Hedef kişiyi doğru seçmek
- 7.2 Eğitimin planlanması
- 7.3 Eğitimin uygulanması – örnek akış
- 7.4 Kişiyi taramaya ikna etmek: Sağlık İnanç Modeli ile düşünmek
- 7.5 "Haftada en az 15 kişi" hedefini tutturmak
- 7.6 Omaha ile kayıt (kısaca)

8. ÖRNEK CEVAPLAR ("Anlat" soruları)

- 8.1 "Bir kadına KKMM'yi nasıl öğretirsin?"
- 8.2 "55 yaşındaki bir erkeğe GGT kitini nasıl verirsin?"
- 8.3 "HPV testine gelen kadına ne anlatırsın?"

9. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – Kanser Taramaları Çalışma Notu

Bu not, ASM'de yapılan kanser tarama hizmetlerini baştan sona anlatır: **meme, rahim ağzı (serviks) ve kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taramaları**; **kendi kendine meme muayenesinin (KKMM) öğretilmesi**, **HPV-smear örneği alımına hazırlık ve örnek alma**, **gaitada gizli kan testi (GGT) kitinin verilmesi**; tarama sonuçlarının ne anlama geldiği, sonuç pozitif çıkınca ne yapılacağı ve kanser tarama eğitiminin nasıl yapılacağı.

Değerlendirme formlarında kanser taramaları üç yerde karşına çıkar:

- **FR.184 beceri 10:** "Kanser tarama programları için gerekli işlemleri (**GGT, KKMM, HPV-SMEAR**) yapabilme/uygulayabilme/anlatabilme"
- **FR.185 madde 23:** "ASM'de kanser tarama konularında eğitim yapmak (sağlık eğitim planı oluşturup, en az 1 materyal kullanarak) (**her öğrenci her hafta en az 15 kişi**) (fotoğraflarla kanıtlayarak)"
- **FR.186 madde 13:** "ASM'de saha çalışmasına çıkılan **her gün** kanser tarama konularında **en az 1 eğitim** yapmak (bireye özgü eğitim planı oluşturma, uygulama ve eğitimin değerlendirmesi)"

Yani hem **uygulamayı yapabilmen**, hem **kişiye anlatabilmen**, hem de **düzenli eğitim verebilmen** bekleniyor.

---

1. Temel kavramlar

1.1 Tarama nedir?

Tarama, hiçbir yakınması ve belirtisi olmayan, kendini sağlıklı hisseden kişilerde, hastalığı **henüz belirti vermeden** ya da kansere dönüşmeden önceki **öncü (prekanseröz) aşamada** yakalamak için yapılan testlerdir. Burada kilit nokta **"belirtisi olmayan kişi"**dir. Memesinde kitle fark eden, makattan kanaması olan ya da ilişki sonrası kanaması olan bir kadın "taramaya" değil, **doğrudan hekime ve tanısal incelemeye** yönlendirilir; çünkü artık belirti vardır.

Kanser taraması bir **ikincil koruma** uygulamasıdır:

- **Birincil koruma**, kanserin hiç oluşmamasını hedefler: sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, hareket etmek, alkolden uzak durmak, güneşten korunmak, **HPV ve Hepatit B aşıları**.
- **İkincil koruma**, kanseri erken evrede ya da öncü lezyon aşamasında bulmayı hedefler: **tarama programları** ve kişinin **erken uyarı belirtilerini tanıyıp hemen başvurması**.
- **Üçüncül koruma**, tanı konmuş kanserde komplikasyonları ve sakatlığı azaltmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefler: tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım.

1.2 Neden her kanser için tarama yok?

Bir kanser için toplum tabanlı tarama programı yapılabilmesi için şu koşulların sağlanması gerekir:

- Kanser toplumda **sık görülen ve önemli** bir sağlık sorunu olmalı.
- Belirti vermeden önceki uzun bir **erken dönemi** olmalı ve bu dönem bir testle saptanabilmeli.
- Erken dönemde yakalandığında **etkili bir tedavisi** olmalı ve erken tedavi ölümleri gerçekten azaltmalı.
- Test **basit, güvenli, ucuz, kabul edilebilir** ve **güvenilir** olmalı.
- Pozitif çıkanlar için tanı ve tedavi olanakları hazır olmalı; program **sürekli** olmalı ve maliyeti yararına değmeli.

Bu koşulları en iyi karşılayan kanserler **meme, serviks ve kolorektal kanserlerdir**. Bu nedenle Türkiye'de (ve birçok ülkede) **bu üç kanser için ulusal tarama programı** vardır. Akciğer, prostat, mide, yumurtalık gibi kanserler için ülkemizde toplum tabanlı ulusal tarama programı yoktur; bunlarda korunma ve erken belirtilerin tanınması önemlidir.

1.3 Bir tarama testinin sonucu nasıl anlaşılmalı?

Hiçbir tarama testi kusursuz değildir:

- **Yanlış pozitif:** Test "anormal" çıkar ama kişide kanser yoktur. Kişi gereksiz yere kaygılanabilir ve ileri inceleme yapılır. Örneğin gaitada gizli kan testi hemoroid nedeniyle pozitif çıkabilir.
- **Yanlış negatif:** Test "normal" çıkar ama kişide hastalık vardır. Bu nedenle negatif sonuç alan kişiye de **belirtileri anlatılır** ve "bir sonraki taramanı kaçırma, arada belirti olursa beklemeden gel" denir.
- **Duyarlılık**, testin hastaları doğru yakalama gücüdür; **özgüllük**, sağlam kişileri doğru ayırma gücüdür.

Bunun pratikteki anlamı şudur: Kişiye her zaman **"Tarama pozitif = kanser değil, ileri inceleme gerekiyor"** ve **"Tarama negatif = belirtileri yine de izle ve bir sonraki taramaya gel"** mesajı verilir.

---

2. Türkiye'de kanser tarama programı

2.1 Ulusal tarama standartları (ezberlenecek)

- **Meme kanseri: 40–69 yaş** arası kadınlara **2 yılda bir mamografi**; buna klinik meme muayenesi eşlik eder. Kadınların **ayda bir kendi kendine meme muayenesi** yapması (meme farkındalığı) önerilir.
- **Serviks (rahim ağzı) kanseri: 30–65 yaş** arası kadınlara **5 yılda bir HPV-DNA testi** (gerektiğinde smear/sitoloji ile birlikte).
- **Kolorektal kanser: 50–70 yaş** arası kadın ve erkeklere **2 yılda bir gaitada gizli kan testi**; ayrıca **10 yılda bir kolonoskopi**.

Kolay ezber: **"Meme 40'ta başlar, 2 yılda bir. Rahim ağzı 30'da başlar, 5 yılda bir. Bağırsak 50'de başlar, 2 yılda bir."**

2.2 Hizmet nerede ve nasıl verilir?

- **KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri):** İl ve ilçelerde bulunan, mamografi, HPV-smear, gaitada gizli kan testi ve eğitim hizmetlerini veren merkezlerdir.
- **Aile Sağlığı Merkezleri:** Kayıtlı nüfus içinde hedef yaştaki kişileri belirler, davet eder, **GGT kitini verir ve numuneyi alır**, **HPV-smear örneği alır** (eğitimli ebe/hemşire/hekim tarafından), kadınları **mamografi için KETEM'e yönlendirir**, sonuçları takip eder.
- **Mobil tarama araçları** ve toplum içinde tarama günleri.
- Kişiler e-Nabız ve SMS ile taramaya davet edilebilir.
- **Tarama hizmetleri ücretsizdir.** Bu bilgi kişilerin taramaya katılmasında önemli bir ikna noktasıdır.

2.3 Kanser taramasında ASM hemşiresinin görevleri

1. **Hedef nüfusu belirleme:** Kayıtlı nüfusta 30–65 yaş kadınlar, 40–69 yaş kadınlar, 50–70 yaş kadın ve erkekler listelenir; kimin taramasının eksik ya da süresinin dolmuş olduğu saptanır.
2. **Davet etme:** Telefon, SMS, ASM'ye herhangi bir nedenle gelen kişiyi o anda sorgulama, ev ziyaretleri.
3. **Eğitim ve danışmanlık:** Taramanın amacı, ücretsiz olduğu, nasıl yapıldığı, korkuların ve yanlış inanışların konuşulması.
4. **Test uygulama:** GGT kitinin verilmesi ve kullanımının öğretilmesi; HPV-smear örneğine hazırlık ve örnek alma (ya da alana yardım); KKMM öğretimi; klinik meme muayenesi (eğitimliyse).
5. **Örneklerin doğru etiketlenmesi ve gönderilmesi.**
6. **Sonuç takibi:** Sonucun kişiye bildirilmesi; **pozitif sonuçlularda ileri incelemeye (kolonoskopi, kolposkopi, meme ultrasonu/biyopsi) gidip gitmediğinin takibi**. Pozitif sonucu olup ileri incelemeye gitmeyen kişi, taramanın amacının boşa gitmesi demektir; bu yüzden takip en önemli görevlerden biridir.
7. **Kayıt** ve bir sonraki tarama tarihinin planlanması.
8. **Toplum eğitimi:** Bekleme salonunda, okulda, işyerinde, kurumlarda kanser tarama eğitimleri.

2.4 ASM'ye gelen bir kişinin tarama durumunu sorgulama

Hangi nedenle gelmiş olursa olsun, hedef yaş grubundaki her kişiye tarama durumu sorulmalıdır. Düşünme yolu şöyledir: **Yaşı kaç? → Hangi taramaların hedefinde? → En son ne zaman yaptırdı? → Eksik ya da süresi dolmuşsa bugün ne yapabilirim?**

Örnekler:

- **35 yaşında kadın:** Serviks taramasının hedefinde (30–65). Son HPV testinin tarihi sorulur; hiç yaptırmamışsa ya da 5 yıl geçmişse HPV-smear için randevu verilir. Meme için henüz mamografi yaşında değildir ama **KKMM öğretilir**.
- **47 yaşında kadın:** Hem **serviks** (5 yılda bir) hem **meme** (2 yılda bir mamografi) taramasının hedefinde. İkisi de sorgulanır; mamografi için KETEM'e yönlendirme yapılır, KKMM öğretilir/tekrarlanır.
- **58 yaşında kadın: Üç taramanın da** hedefinde: serviks, meme ve kolorektal. Eksik olanlar belirlenir; GGT kiti aynı gün verilebilir.
- **62 yaşında erkek: Kolorektal** taramanın hedefinde. Son GGT tarihi sorulur, kit verilir. (Prostat için toplum tabanlı tarama yoktur; kişi isterse hekimiyle konuşarak karar verebileceği söylenir.)
- **72 yaşında kadın:** Ulusal program yaş aralıklarının dışındadır; ancak yakınması varsa (memede kitle, kanama vb.) hekime yönlendirilir. Yaş aralığı dışında rutin tarama kararı hekime aittir.

---

3. MEME KANSERİ VE TARAMASI

3.1 Bilmen gerekenler

Meme kanseri kadınlarda **en sık görülen kanserdir** ve kadınlarda kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Erken evrede yakalandığında tedavi başarısı çok yüksektir; bu yüzden tarama çok önemlidir. Erkeklerde de görülebilir ama çok nadirdir.

3.2 Risk faktörleri – neden risk oluştururlar?

Meme kanseri risk faktörlerinin çoğu, kadının yaşamı boyunca **östrojen hormonuna maruz kaldığı sürenin uzunluğu** ile ilişkilidir. Bu mantığı bilirsen listeyi ezberlemek kolaylaşır.

- **Kadın olmak ve yaşın ilerlemesi:** En önemli iki risk faktörüdür; risk özellikle 40 yaşından sonra artar.
- **Aile öyküsü:** Anne, kız kardeş ya da kızında (birinci derece akraba) meme ya da yumurtalık kanseri olması, özellikle genç yaşta olmuşsa riski artırır. **BRCA1/BRCA2** gen değişiklikleri riski belirgin artırır. Ancak meme kanseri olan kadınların **çoğunun ailesinde meme kanseri yoktur**; "ailemde yok, bana bir şey olmaz" düşüncesi yanlıştır.
- **Kendisinde daha önce meme kanseri** ya da bazı iyi huylu meme hastalıkları.
- **Erken adet görme (12 yaşından önce)** ve **geç menopoz (55 yaşından sonra):** Östrojene maruz kalınan süre uzar.
- **Hiç doğum yapmamış olmak** ya da **ilk doğumun 30 yaşından sonra** olması.
- **Emzirmemiş olmak:** Emzirme koruyucudur; emzirme süresi uzadıkça koruma artar.
- **Menopoz sonrası uzun süreli hormon tedavisi.**
- **Menopoz sonrası obezite:** Menopozdan sonra yağ dokusu östrojen kaynağı olur.
- **Alkol kullanımı** ve **fiziksel hareketsizlik.**
- Genç yaşta **göğüs bölgesine radyoterapi** almış olmak.

Koruyucu etkenler: Emzirme, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı kilonun korunması, alkol kullanmama.

Yüksek riskli kadınlar (ailesinde genç yaşta meme/yumurtalık kanseri olan, birden fazla akrabasında meme kanseri olan, BRCA taşıyıcısı olduğu bilinen, genç yaşta göğsüne radyoterapi almış kadınlar) **hekime yönlendirilir**; bu kadınlarda taramaya daha erken yaşta ve farklı yöntemlerle başlanabilir.

3.3 Meme kanserinin uyarı belirtileri

Kadına şu değişikliklerden biri olursa, bir sonraki taramayı beklemeden başvurması öğretilir:

- Memede ya da koltuk altında **ele gelen kitle, sertlik, kalınlaşma**
- Memenin büyüklüğünde ya da şeklinde **yeni ortaya çıkan fark**
- Meme cildinde **içe çekilme, çukurlaşma**, **portakal kabuğu görünümü**, kızarıklık, ısı artışı
- Meme başında **yeni gelişen içe çekilme** ya da yön değişikliği
- Meme başından **kendiliğinden gelen, özellikle kanlı akıntı**
- Meme başında ve çevresinde **egzama gibi pullanma, kabuklanma, yara**
- Koltuk altında ya da köprücük kemiği üstünde **şişlik**

Memede ağrı çoğunlukla hormonal değişikliklere bağlıdır ve tek başına kanser belirtisi değildir; ancak tek bir noktada sürekli ve adetle ilişkisiz ağrı da değerlendirilmelidir. **Memede bulunan kitlelerin çoğu iyi huyludur**; ama hangisinin iyi huylu olduğuna ancak hekim karar verebilir.

3.4 Kendi kendine meme muayenesi (KKMM)

KKMM'nin amacı, kadının **kendi memesinin normal yapısını tanıması** ve bir değişiklik olduğunda bunu fark edip hemen başvurmasıdır (meme farkındalığı). KKMM **mamografinin yerini tutmaz**; mamografi elle hissedilemeyecek kadar küçük kanserleri bulabilir. Bu yüzden 40 yaşından sonra KKMM yapan kadın da mamografisini aksatmamalıdır.

Ne zaman yapılır?

- **Adet gören kadın:** Her ay, **adet kanaması bittikten sonraki 5.–7. günlerde**. Bu günlerde memeler hormon etkisinden kurtulmuştur; daha az şiş, daha az hassas ve daha yumuşaktır, bu yüzden değişiklikleri fark etmek kolaydır. Adetten önceki günlerde memeler doğal olarak şişkin, ağrılı ve düğümlü olabilir; bu dönemde yapılan muayene kadını gereksiz yere korkutabilir.
- **Menopozdaki kadın, gebe, emziren, adetleri düzensiz olan ya da rahmi alınmış kadın: Her ayın aynı günü** (örneğin her ayın 1'i ya da doğum gününün denk geldiği gün). Kolay hatırlanacak bir gün seçmesi önerilir.
- Kadınların genç yaştan itibaren (genellikle 20 yaşından sonra) memelerini tanımaya başlaması önerilir.

KKMM'nin iki aşaması

Birinci aşama – Ayna karşısında bakma (gözle muayene): Kadın belden yukarısı çıplak olarak, iyi ışıklı bir yerde, büyük bir aynanın karşısında durur. Memelerine **dört farklı pozisyonda** bakar:

1. **Kollar iki yanda serbestçe sarkarken.**
2. **Kollar başın üzerine kaldırılmışken** (bu pozisyonda cilt çekintileri daha belirgin görülür).
3. **Eller belde, kalçalara doğru bastırarak göğüs kaslarını kasarken.**
4. **Hafifçe öne eğilmişken** (memeler serbestçe sarkar; şekil farkı ve çekinti görünür).

Her pozisyonda şunlara bakar: İki memenin büyüklüğü ve şekli arasında **yeni bir fark** var mı? Ciltte **çekinti, çukurlaşma, portakal kabuğu görünümü**, kızarıklık, döküntü var mı? Meme başı **içe çekilmiş** ya da yönü değişmiş mi? Meme başında **yara, kabuklanma, pullanma** var mı? Sutyende ya da meme başında **akıntı izi** var mı? Kadına şu bilgi verilir: İki memenin tam olarak aynı büyüklükte olmaması normaldir; önemli olan **yeni ortaya çıkan** farktır.

İkinci aşama – Elle muayene (palpasyon): Elle muayene **yatarak** yapılırsa meme dokusu göğüs duvarına yayılır ve daha iyi muayene edilir; ayrıca **duşta, sabunlu ve ıslak ciltle** de yapılabilir (parmaklar kolay kayar).

1. **Pozisyon:** Kadın sırtüstü yatar. Muayene edeceği memenin tarafındaki **omzunun altına küçük bir yastık ya da katlanmış havlu** koyar ve **o taraftaki kolunu başının altına** alır. Örneğin sağ memeyi muayene ederken sağ omzun altında yastık, sağ kol başın altındadır.
2. **Hangi el, hangi parmaklar?** Muayene **karşı elle** yapılır (sağ meme için sol el). **İşaret, orta ve yüzük parmaklarının iç yüzleri (parmak uçlarının yumuşak kısımları)** kullanılır; parmak uçlarıyla (tırnak tarafıyla) dürtülmez, parmaklar düz ve birbirine bitişik tutulur.
3. **Hareket:** Parmaklarla **bozuk para büyüklüğünde küçük daireler** çizilir; her noktada daire bitince parmaklar kaldırılmadan bir sonraki noktaya kaydırılır.
4. **Üç basınç düzeyi:** Her noktada önce **hafif** (cildin hemen altındaki doku), sonra **orta** (meme dokusunun ortası), sonra **derin** (göğüs kaslarına ve kaburgalara yakın doku) basınç uygulanır. Böylece memenin tüm katmanları muayene edilir.
5. **Muayene düzeni (patern):** Memenin hiçbir bölgesi atlanmamalıdır. En etkili düzen **dikey şeritler** yöntemidir: koltuk altından başlayıp yukarıdan aşağıya, sonra bir parmak eni içeri kayıp aşağıdan yukarıya, bir çim biçme makinesi gibi tüm meme taranır. Alternatif olarak memenin dışından meme başına doğru daralan daireler ya da saat yönünde yelpaze şeklinde (radyal) muayene de yapılabilir; önemli olan kadının **her ay aynı yöntemi** kullanmasıdır.

6. **Muayene edilecek alan:** Memenin sınırları sanıldığından geniştir: **yukarıda köprücük kemiğine**, **aşağıda meme altı kıvrımına (sutyen çizgisi)**, **içte göğüs kemiğine**, **dışta koltuk altının ortasına** kadar. **Koltuk altı** ve memenin **üst-dış kısmından koltuk altına uzanan "kuyruk" bölgesi** mutlaka muayene edilir; **meme kanserleri en sık memenin üst-dış bölgesinde** görülür.
7. **Meme başı:** Meme başı ve çevresi gözle ve parmaklarla değerlendirilir. Meme başını sıkarak akıntı aramak gerekmez; önemli olan **kendiliğinden gelen**, özellikle **kanlı** ya da **tek bir kanaldan gelen** akıntıdır.
8. Aynı işlemler **diğer meme için** tekrarlanır.
9. Kadın **ayakta ya da otururken** koltuk altlarını da muayene edebilir: Muayene edilecek taraftaki kol hafifçe yana açılır, karşı elle koltuk altı derinliğine kadar yoklanır.

Ne bulursa ne yapacak? Memede yeni bir kitle, sertlik, kalınlaşma, cilt ya da meme başında değişiklik, kendiliğinden akıntı fark ederse **panik yapmadan ama bir sonraki ayı beklemeden** ASM'ye ya da KETEM'e başvurur.

Kadına söylenecek önemli bilgi: Normal meme dokusu düz ve pürüzsüz değildir; özellikle üst-dış bölgelerde ve meme altında **doğal bir düğümlülük ve kalınlık** hissedilebilir. Kadın kendi memesini her ay muayene ettikçe "kendi normalini" öğrenir ve **yeni olan, diğer memede olmayan, kalıcı** değişikliği daha kolay fark eder.

3.5 Klinik meme muayenesi (KMM)

Klinik meme muayenesi, eğitimli bir sağlık profesyoneli (hekim ya da bu konuda eğitim almış hemşire/ebe) tarafından yapılır ve mamografiyle birlikte taramanın bir parçasıdır.

- **Öykü:** Yaş, adet durumu, son adet tarihi, menopoz, doğum ve emzirme öyküsü, hormon kullanımı, aile öyküsü, daha önceki meme sorunları ve mamografiler, şu anki yakınmalar.
- **Bakı:** Kadın oturur pozisyonda, kollar yanda, sonra başın üstünde, sonra eller belde; iki meme karşılaştırılarak cilt, meme başı, simetri değerlendirilir.
- **Lenf bezlerinin muayenesi:** Kadın oturur pozisyondayken koltuk altları, köprücük kemiği üstü ve altı lenf bezleri yoklanır.
- **Memelerin elle muayenesi:** Kadın yatar pozisyonda, kol başın altında, dikey şerit yöntemiyle, üç basınç düzeyiyle, köprücük kemiğinden meme altı kıvrımına ve göğüs kemiğinden koltuk altına kadar tüm alan muayene edilir.
- Muayene sırasında **mahremiyet** sağlanır, kadına ne yapıldığı anlatılır; bu fırsat **KKMM'yi öğretmek** için kullanılır.
- Anormal bulgu hekime bildirilir; kadın ileri incelemeye (ultrason, mamografi, gerekirse biyopsi) yönlendirilir.

3.6 Mamografi

Nedir? Memenin düşük doz X-ışını ile çekilen görüntüsüdür. Elle hissedilemeyecek kadar küçük kitleleri ve kanserin erken belirtisi olabilecek mikro kireçlenmeleri gösterebilir. Meme sağ ve sol olarak, genellikle iki farklı açıdan, iki plak arasında kısa süre sıkıştırılarak çekilir.

Kime, ne sıklıkla? Ulusal programa göre **40–69 yaş kadınlara 2 yılda bir.**

Kadına anlatılacak hazırlık:

- Çekim günü koltuk altlarına ve memelere **deodorant, pudra, parfüm, krem sürmemelidir**; bunların içindeki maddeler görüntüde kireçlenme gibi görünüp yanlış sonuca yol açabilir.
- Adet gören kadınlar için çekim, mümkünse **adet bittikten sonraki hafta** planlanır; memeler daha az hassas olduğu için sıkıştırma daha az rahatsız edicidir.
- Kolay çıkarılabilen iki parçalı kıyafet giymesi önerilir.
- **Önceki mamografi görüntülerini ve raporlarını** getirmelidir; karşılaştırma yapılır.

- Meme protezi (implant) varsa, gebelik olasılığı varsa ya da emziriyorsa çekimden önce söylemelidir.
- Sıkıştırma sırasında birkaç saniye **basınç ya da ağrı** hissedebileceği, bunun kısa süreceği ve görüntünün kalitesi için gerekli olduğu anlatılır.

Sık sorulan sorular ve yanlış inanışlar:

- *"Mamografi radyasyon veriyor, zararlı."* → Kullanılan doz çok düşüktür; 40 yaşından sonra 2 yılda bir çekilmesinin erken tanıdaki yararı, radyasyonun olası riskinden çok daha fazladır.
- *"Mamografide meme sıkıştırılınca kanser yayılır."* → Bu doğru değildir.
- *"Şikâyetim yok, gerek yok."* → Taramanın amacı tam da şikâyet yokken, erken dönemde yakalamaktır.
- *"Ailemde meme kanseri yok."* → Meme kanseri olan kadınların çoğunun ailesinde meme kanseri yoktur.
- *"Ya bir şey çıkarsa? Bilmemek daha iyi."* → Erken evrede bulunan meme kanserinde tedavi başarısı çok yüksektir; geç kalmak tedaviyi zorlaştırır.

Sonuç nasıl raporlanır? Mamografi sonuçları genellikle **BI-RADS** adı verilen bir sistemle kategorilere ayrılır. Kabaca: **0** ek görüntüleme gerekiyor; **1** normal; **2** iyi huylu bulgu; **3** büyük olasılıkla iyi huylu, kısa aralıklı kontrol önerilir; **4 ve 5** şüpheli bulgu, biyopsi gerekir; **6** daha önce kanser tanısı konmuş. Kategori 1 ve 2 olan kadın 2 yıl sonra taramaya devam eder; diğer kategorilerde hekimin önerdiği ileri incelemenin yapılıp yapılmadığı takip edilir.

---

4. SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ VE TARAMASI

4.1 Bilmen gerekenler – HPV ile ilişki

Rahim ağzı kanserlerinin **neredeyse tamamı**, **insan papilloma virüsü (HPV)** adlı virüsün **yüksek riskli tiplerinin** (en önemlileri **tip 16 ve 18**) kalıcı enfeksiyonu sonucu gelişir.

- HPV **cinsel temasla** bulaşır ve çok yaygındır; cinsel yaşamı olan kişilerin büyük çoğunluğu yaşamlarının bir döneminde HPV ile karşılaşır.
- Enfeksiyonların **büyük çoğunluğu** bağışıklık sistemi tarafından **1–2 yıl içinde kendiliğinden temizlenir**.
- Bir kısmında yüksek riskli HPV **kalıcı** hale gelir ve rahim ağzında yıllar içinde **öncü (prekanseröz) hücre değişikliklerine** yol açar. Bu öncü değişikliklerin kansere dönüşmesi genellikle **10–20 yıl** gibi uzun bir süre alır.
- Bu uzun süre içinde tarama ile öncü değişiklikler **bulunup basit işlemlerle tedavi edilebilir**. Bu yüzden rahim ağzı kanseri **önlenebilir bir kanserdir**.

4.2 Risk faktörleri

- Kalıcı yüksek riskli HPV enfeksiyonu (temel neden)
- **Erken yaşta** cinsel ilişkiye başlama
- Kendisinin ya da eşinin **çok sayıda cinsel eşinin** olması
- **Sigara içme** (rahim ağzı hücrelerinde HPV'nin temizlenmesini zorlaştırır)
- **Bağışıklık sisteminin baskılanması** (HIV, organ nakli sonrası ilaçlar)
- Çok sayıda doğum, uzun süreli (5 yıldan fazla) kombine doğum kontrol hapı kullanımı
- Cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar
- **Taramaya hiç katılmamış ya da düzensiz katılmış olmak** (en önemli değiştirilebilir risklerden biri)

4.3 Uyarı belirtileri

Erken dönemde genellikle **hiçbir belirti yoktur** – taramanın önemi buradan gelir. İlerlemiş dönemde:

- **Cinsel ilişki sonrası kanama**
- **Adet aralarında kanama**, **menopozdan sonra kanama**
- Kötü kokulu, sulu ya da kanlı **vajinal akıntı**
- Kasık, bel ya da cinsel ilişki sırasında ağrı Bu belirtileri olan kadın tarama sırası beklemeden **hekime** yönlendirilir.

4.4 Korunma

- **HPV aşısı (birincil koruma):** En etkili olduğu dönem, cinsel yaşam başlamadan önceki dönemdir (çocukluk-erken ergenlik). Ülkemizde ulusal aşı programına alınacağı açıklanmıştı; ancak bu notun hazırlandığı tarihteki bilgilere göre henüz rutin takvimde değildir ve ücretli olarak uygulanmaktadır. Aşılı kadınlar da **taramaya devam etmelidir**, çünkü aşı tüm yüksek riskli tiplere karşı koruma sağlamaz.
- **Düzenli tarama (ikincil koruma):** 30–65 yaş, 5 yılda bir HPV testi.
- **Kondom kullanımı** riski azaltır (tam koruma sağlamaz).
- **Sigarayı bırakma.**

4.5 Tarama testleri

- **HPV-DNA testi:** Rahim ağzından alınan hücre örneğinde **yüksek riskli HPV olup olmadığına** bakar. Kanseri değil, kanser riskini gösteren virüsü saptar. Duyarlılığı yüksektir; negatif sonuç kadının önümüzdeki yıllarda öncü lezyon geliştirme olasılığının çok düşük olduğunu gösterir, bu yüzden tarama aralığı **5 yıl** olabilir.
- **Smear (Pap smear, servikal sitoloji):** Aynı örnekteki **hücrelerin mikroskopta incelenmesi**dir; hücrelerde öncü değişiklik olup olmadığını gösterir. Programda özellikle HPV pozitif çıkan kadınlarda ne yapılacağına karar vermek için kullanılır.
- Örnek genellikle **sıvı bazlı** bir tüpe alınır; aynı örnekten hem HPV testi hem sitoloji çalışılabilir.

Kime? 30–65 yaş arası, cinsel yaşamı olmuş kadınlara **5 yılda bir**. 65 yaşından sonra, önceki düzenli taramaları normal olan kadınlarda tarama sonlandırılabilir. Rahmi ve rahim ağzı alınmış kadınlarda tarama gerekip gerekmediğine hekim karar verir.

4.6 HPV-smear öncesi kadına verilecek hazırlık talimatı

Örneğin kaliteli olması ve sonucun güvenilir olması için kadına randevu verirken şunlar anlatılır:

- Testten önceki **48 saat** boyunca **cinsel ilişkide bulunmamalı**.
- **Vajinal duş yapmamalı** (vajina içini su ya da başka bir sıvıyla yıkamamalı); dış genital bölgenin normal temizliği yapılabilir.
- **Tampon, vajinal krem, fitil, jel ya da ilaç kullanmamalı.**
- **Adet kanaması sırasında test yapılmaz**; kan hücreleri örneği bozar. Test, adet kanaması bittikten birkaç gün sonra, bir sonraki adetten önceki bir güne planlanır.
- Vajinal enfeksiyon tedavisi görüyorsa tedavi bittikten sonra gelmesi önerilir.
- Gebeyse ya da gebelik şüphesi varsa söylemelidir.
- İşlem **kısa süren ve genellikle ağrısız** bir işlemdir; hafif bir baskı ya da rahatsızlık hissedebilir; sonrasında birkaç saat hafif lekelenme olabilir.

4.7 Örnek alma işlemi ve hemşirenin rolü

Örnek, bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından alınır. Öğrenci olarak sen genellikle hazırlık, kadının desteklenmesi, malzeme, etiketleme ve kayıt aşamalarında görev alırsın; işlemin basamaklarını da anlatabilmen beklenir.

1. Hazırlık:

- Kadının **yaşı ve son tarama tarihi** kontrol edilir (hedef grupta mı, 5 yıl dolmuş mu?).
- Hazırlık talimatlarına uyup uymadığı sorulur (48 saat ilişki/duş/ilaç yok, adet döneminde değil).
- **Malzeme hazırlanır:** Uygun boyda **spekulum** (tek kullanımlık), **servikal fırça (örnek alma fırçası)** ya da spatula ve fırça, **sıvı bazlı örnek tüpü**, eldiven, ışık kaynağı, örtü, **etiket** ve **istem/kayıt formu**.

2. Kadının hazırlanması:

- Kendini tanıt, işlemi **sade bir dille anlat**, sorularını yanıtla, **kaygısını azalt**, onamını al.
- **Mahremiyet:** Kapı kapalı, paravan, örtü; kadın tercih ederse kadın sağlık çalışanı ve/veya bir refakatçi.
- Mesanesini boşaltması istenir.
- Belden aşağısını soyunur, örtü verilir; jinekolojik masada **litotomi pozisyonuna** (sırtüstü, dizler bükülü ve ayaklar desteklerde) yerleştirilir.

- Kadına derin ve yavaş nefes alması, kalça ve karın kaslarını gevşetmesi söylenir.

3. Örneğin alınması (basamaklar):

- Eldiven giyilir; dış genital bölge gözle değerlendirilir (yara, siğil, akıntı).
- Spekulum, gerekirse ılık su ile ıslatılarak (kayganlaştırıcı jel örneği bozabileceğinden kurum talimatına göre) yan çevrilmiş olarak nazikçe yerleştirilir, sonra düzeltilip açılır ve **rahim ağzı görünür hale getirilir.**
- Rahim ağzı görülür; akıntı, kanama, yara, kitle gibi gözle görülen bir anormallik varsa hekime bildirilir.
- **Servikal fırça** rahim ağzına yerleştirilir ve üretici talimatına göre (genellikle aynı yönde birkaç tam tur) döndürülerek hücre örneği alınır. Rahim ağzının dış yüzü ile kanal ağzının birleştiği bölge (kanserin en sık başladığı **dönüşüm bölgesi**) mutlaka örneklenmelidir.
- Fırçanın ucu **hemen sıvı bazlı tüpe** daldırılır, talimata göre çalkalanır ya da ucu tüpün içine bırakılır; tüpün kapağı sıkıca kapatılır.
- Spekulum nazikçe kapatılarak çıkarılır.

4. İşlem sonrası:

- Kadının giyinmesine yardım edilir; hafif lekelenme olabileceği söylenir.
- Tüp **hemen, kadının yanında** etiketlenir (ad-soyad, kimlik numarası, tarih); **istem formu eksiksiz** doldurulur (son adet tarihi, gebelik, menopoz, daha önceki tarama ve sonuçlar, şikâyetler).
- Örnek uygun koşulda laboratuvara gönderilir.
- Kadına **sonucu nasıl ve ne zaman öğreneceği** anlatılır; iletişim bilgisinin doğru olduğu kontrol edilir.
- Kayıt yapılır ve sonucun takibi planlanır.

4.8 Sonuçlar ne anlama gelir ve ne yapılır?

Kesin yol haritasını hekim ve tarama merkezi belirler; ancak genel mantığı bilmen ve kadına sade bir dille anlatabilmen gerekir:

- **HPV negatif:** Yüksek riskli HPV saptanmadı. Kadın **5 yıl sonra** yeniden taranır. Bu arada yukarıdaki uyarı belirtilerinden biri olursa beklemeden başvurur.
- **HPV pozitif (tip 16 ya da 18):** Kanser riski en yüksek tipler olduğu için kadın genellikle **kolposkopiye** (rahim ağzının özel bir büyüteçle incelenmesi, gerekirse küçük parça alınması) yönlendirilir.
- **HPV pozitif (diğer yüksek riskli tipler):** Aynı örneğin **sitoloji (smear) sonucuna** bakılır. Hücrelerde anormallik varsa kolposkopiye yönlendirilir; sitoloji normalse genellikle **1 yıl sonra** HPV testi tekrarlanır (çoğu enfeksiyonun bu sürede temizlenmesi beklenir).

HPV pozitif çıkan kadına danışmanlık – çok önemli:

- "**HPV pozitifliği kanser demek değildir.** Çok yaygın bir virüstür; çoğu kadında kendiliğinden geçer. Test, rahim ağzınızı daha yakından izlememiz gerektiğini gösteriyor."
- "Virüs yıllarca belirti vermeden kalabilir; bu sonuç **eşinizin ya da sizin yakın zamanda bir ilişkiden enfekte olduğunuz anlamına gelmez.**" Bu açıklama aile içi sorunları ve damgalanmayı önlemek için önemlidir.
- "Önerilen kontrolü ya da kolposkopiyi kaçırmamanız gerekir; erken dönemde bulunan değişiklikler basit işlemlerle tedavi edilir."
- **Sigara içiyorsa bırakması** önerilir; bağışıklık sisteminin virüsü temizlemesine yardımcı olur.
- Kadının kolposkopiye gidip gitmediği takip edilir.

---

5. KOLOREKTAL (KALIN BAĞIRSAK) KANSERİ VE TARAMASI

5.1 Bilmen gerekenler

Kolorektal kanser hem kadınlarda hem erkeklerde sık görülen kanserlerdendir. Çoğu kolorektal kanser, bağırsak duvarında oluşan **iyi huylu kabarıklıklardan (poliplerden)** yıllar içinde (genellikle **10–15 yıl**) gelişir. Bu nedenle tarama iki şekilde yarar sağlar: **kanseri erken evrede bulur** ve kolonoskopi sırasında **polipler alınarak kanser hiç oluşmadan önlenir.**

5.2 Risk faktörleri

- **50 yaşın üstü** olmak (en önemli risk faktörü)
- **Birinci derece akrabada** (anne, baba, kardeş, çocuk) kolorektal kanser ya da polip öyküsü
- Kişinin kendisinde daha önce **polip** ya da kolorektal kanser
- **İnflamatuvar bağırsak hastalığı** (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
- Kalıtsal bağırsak kanseri sendromları
- **Kırmızı et ve işlenmiş et** (salam, sosis, sucuk) ağırlıklı beslenme, **düşük lifli** beslenme
- **Obezite**, **fiziksel hareketsizlik**
- **Sigara** ve **alkol**
- Tip 2 diyabet

Koruyucu etkenler: Sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin (lifli) beslenme; düzenli fiziksel aktivite; sağlıklı kilo; işlenmiş eti sınırlama; sigara ve alkolden uzak durma; düzenli tarama.

Yüksek riskli kişiler (ailesinde kolorektal kanser olanlar, inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar, daha önce polip aldıranlar) genel programdan farklı olarak **daha erken yaşta ve doğrudan kolonoskopi** ile izlenebilir; bu kişiler **hekime yönlendirilir.**

5.3 Uyarı belirtileri

- **Dışkılama alışkanlığında değişiklik:** Yeni başlayan ve süren kabızlık, ishal ya da ikisinin dönüşümlü olması
- **Dışkıda kan** ya da makattan kanama; siyah, katran renginde dışkı
- **Açıklanamayan demir eksikliği anemisi** (özellikle erkeklerde ve menopozdaki kadınlarda; halsizlik, solukluk)
- Dışkı çapında incelme, tam boşalamama hissi
- Geçmeyen karın ağrısı, şişkinlik
- **Açıklanamayan kilo kaybı**

Bu belirtileri olan kişi tarama kiti beklemeden **hekime** yönlendirilir. Özellikle "hemoroidim var, kanama ondandır" diyerek değerlendirme yaptırmamak tehlikelidir.

5.4 Gaitada gizli kan testi (GGT)

Nedir, neden yapılır? Bağırsakta polip ya da kanser varsa, dışkıya **gözle görülemeyecek kadar az** kan karışabilir. Bu teste "gizli" kan testi denmesinin nedeni budur. Test, dışkıdaki bu çok küçük miktardaki insan kanını saptar.

Hangi test? Tarama programında **immünokimyasal test** (insan hemoglobinine özgü antikorlarla çalışan test) kullanılır. Bu test yalnızca insan kanına tepki verdiğinden kişinin test öncesinde **et yememek, bazı sebzelerden ya da ilaçlardan kaçınmak gibi diyet kısıtlamaları yapmasına gerek yoktur.** (Eski tip guaiak testlerinde diyet kısıtlaması gerekiyordu;

bu fark sorulabilir.) Yine de her zaman kitin kendi talimatına uyulur.

Kime, ne sıklıkla? 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere **2 yılda bir.**

Kiti verirken kişiye adım adım anlatılacaklar

Kit verilirken kişiye mutlaka **gösterilerek** anlatılır ve basit, resimli bir talimat kâğıdı verilir. Kişiden anlattıklarını tekrar etmesi istenir.

1. **Tüpün üzerindeki bilgileri kontrol et:** Adın, soyadın (ya da barkod) ve numuneyi alacağın **tarihi** yaz.
2. **Dışkının suya ve idrara karışmasını önle:** Önce idrarını yap. Sonra klozetin içine temiz bir kâğıt, gazete ya da tek kullanımlık bir kap yerleştir ya da temiz, kuru bir kaba dışkıla. Dışkı klozetteki suya düşerse test bozulabilir.
3. **Tüpün kapağını çevirerek aç.** Kapağa bağlı ince bir çubuk vardır.
4. **Çubuğu dışkının birkaç farklı yerine batır ya da sürt;** çubuğun ucundaki oluklu kısım dışkıyla kaplanacak kadar örnek yeterlidir. Fazla almaya gerek yoktur; fazlalık testi bozabilir.
5. **Çubuğu tüpe geri yerleştir ve kapağı sıkıca kapat.** Tüpü açıp kapatmamalı, içindeki sıvıyı dökmemelisin.
6. **Ellerini yıka.**
7. **Numuneyi en kısa sürede** (kitin önerdiği süre içinde, genellikle aynı gün ya da 1–2 gün içinde) ASM'ye getir. Getirene kadar **serin ve güneş görmeyen** bir yerde sakla.

Numune alınmaması gereken durumlar (test ertelenir)

- **Adet kanaması** süresince ve bitiminden sonraki birkaç gün (adet kanı dışkıya karışıp yanlış pozitif sonuç verebilir)
- **Kanayan hemoroid** ya da makattan gözle görülen kanama olduğunda (bu durumda zaten tarama değil hekim değerlendirmesi gerekir)
- **İdrarda kan** olduğunda
- Ağızda, burunda aktif kanama olduğunda

Numune getirildiğinde

Tüpün doğru kapatıldığı, etiket bilgilerinin eksiksiz olduğu, numunenin tarihinin uygun olduğu kontrol edilir; kayıt yapılıp laboratuvara gönderilir; kişiye sonucu nasıl öğreneceği söylenir.

5.5 Sonuçlar ve sonrası

- **GGT negatif:** Dışkıda gizli kan saptanmadı. Kişi **2 yıl sonra** yeniden test yapar. Bu arada uyarı belirtilerinden biri olursa beklemeden başvurur.
- **GGT pozitif:** Dışkıda gizli kan saptandı. Kişi **kolonoskopiye yönlendirilir.**

Pozitif sonucu olan kişiye danışmanlık:

- "Testin pozitif çıkması **kanser olduğunuz anlamına gelmez.** Hemoroid, polip, bağırsakta küçük bir yara gibi birçok neden kanamaya yol açabilir. Ancak nedenini bulmak için kolonoskopi yapılması **şarttır**."
- "Kolonoskopide polip bulunursa genellikle aynı işlemde alınır ve böylece kanser oluşmadan önlenmiş olur."
- **Kolonoskopi hakkında bilgi:** Bağırsağın ucunda kamera olan ince, esnek bir tüple incelenmesidir; genellikle sakinleştirici ilaçla yapılır ve kişi fazla bir şey hissetmez. Öncesinde birkaç gün özel bir beslenme ve bir gün önce bağırsağı temizleyen bir ilaç kullanılır; ayrıntılı hazırlık talimatı kolonoskopi yapılacak merkez tarafından verilir. Kan sulandırıcı ya da şeker ilacı kullananlar bunu hekimine söylemelidir.
- **En sık sorun, pozitif sonuçlu kişinin kolonoskopiye gitmemesidir** (korku, utanç, "kendimi iyi hissediyorum", ulaşım). Hemşire bu engelleri kişiyle konuşur, randevuya yardımcı olur ve **kolonoskopinin yapılıp yapılmadığını takip eder.**

6. DİĞER KANSERLERDE ERKEN TANI VE FARKINDALIK

Bu kanserler için ülkemizde toplum tabanlı ulusal tarama programı yoktur; ancak eğitimlerde sıkça sorulur ve kişilerin erken belirtileri tanıması önemlidir.

Testis kanseri ve testis kendi muayenesi: Özellikle **15–35 yaş** genç erkeklerde görülür. Erkeklere **ayda bir, ılık bir duştan sonra** (skrotum gevşek olduğunda) testislerini muayene etmeleri öğretilir: Her testis iki elin başparmakları üstte, diğer parmaklar altta olacak şekilde nazikçe yuvarlanır; yüzey düz ve pürüzsüz olmalıdır. Testisin arkasında yukarıdan aşağı uzanan yumuşak, kıvrımlı yapı (epididim) normaldir ve kitle sanılmamalıdır. **Sert, ağrısız bir kitle**, testiste büyüme, ağırlık hissi ya da şekil değişikliği fark edilirse hekime başvurulur. İki testisin biraz farklı büyüklükte olması normaldir.

Cilt kanserleri: Benlerde değişiklik **ABCDE** kuralıyla izlenir: **A**simetri (benin iki yarısı birbirine benzemiyor), **B**ordür/kenar düzensizliği, **C**olor/renk farklılıkları (birden fazla renk), **D**iameter/çapın 6 mm'den büyük olması, **E**volving/değişim (büyüme, kaşıntı, kanama). Korunma: 10.00–16.00 saatleri arasında güneşten kaçınma, şapka, güneş gözlüğü, uzun kollu giysi, güneş kremi; solaryumdan uzak durma; çocukları güneş yanığından koruma.

Prostat kanseri: Ülkemizde toplum tabanlı rutin tarama programı yoktur. 50 yaşın üstündeki erkekler (ailesinde prostat kanseri olanlar daha erken) PSA testinin yararlarını ve olası zararlarını (yanlış pozitiflik, gereksiz biyopsi, yavaş seyirli kanserlerin aşırı tedavisi) hekimleriyle konuşarak test yaptırıp yaptırmamaya karar verebilir. İdrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, idrarda kan gibi yakınmalarda hekime başvurulur.

Akciğer kanseri: En önemli risk faktörü **sigaradır**; en etkili korunma **sigaraya hiç başlamamak ya da bırakmak**tır. Ülkemizde toplum tabanlı ulusal akciğer kanseri taraması yoktur. Üç haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, ses kısıklığı, nefes darlığı, açıklanamayan kilo kaybı olan kişi hekime yönlendirilir. Sigara bırakmak isteyenler **ALO 171** hattına ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilir.

Ağız kanserleri: Ağızda iki haftadan uzun süren iyileşmeyen yara, beyaz ya da kırmızı lekeler, şişlik; risk faktörleri sigara, tütün çiğneme ve alkol; düzenli diş hekimi kontrolü.

6.1 Kanserin genel uyarı işaretleri (eğitimde kullan)

- İki-üç haftadan uzun süren öksürük ya da ses kısıklığı
- Yutma güçlüğü, geçmeyen hazımsızlık
- Bağırsak ya da idrar alışkanlıklarında değişiklik
- Olağan dışı kanama ya da akıntı (dışkıda, idrarda, balgamda, vajinadan)
- Memede ya da vücudun başka bir yerinde kitle, kalınlaşma
- İyileşmeyen yara
- Ben ya da siğilde belirgin değişiklik
- Açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk, ateş

6.2 Avrupa Kanserle Mücadele Kodu – 12 öneri (birincil korunma)

1. Hiçbir şekilde tütün kullanma.
2. Evini ve işyerini dumansız tut.
3. Sağlıklı kiloda kalmak için çaba göster.
4. Günlük yaşamında fiziksel olarak aktif ol; oturarak geçirdiğin süreyi azalt.
5. Sağlıklı beslen: tam tahıl, baklagil, sebze ve meyveyi bol tüket; yüksek kalorili gıdaları ve şekerli içecekleri sınırla; işlenmiş etten kaçın, kırmızı eti sınırla; tuzu azalt.

6. Alkol kullanıyorsan sınırla; hiç içmemek kanser önleme açısından en iyisidir.
7. Özellikle çocukları güneşten koru; güneş yanığından kaçın; solaryum kullanma.
8. İşyerinde kansere yol açan maddelerden korun.
9. Evindeki radon düzeyini öğren; yüksekse azaltmak için önlem al.
10. Kadınlar için: Emzirmek kanser riskini azaltır, mümkünse emzir; menopoz döneminde hormon tedavisini sınırla.
11. Çocuklarına **Hepatit B** (yenidoğanlar için) ve **HPV** (kızlar için) aşılarını yaptır.
12. Ulusal kanser tarama programlarına katıl: **kolorektal, meme ve serviks** kanseri.

---

7. KANSER TARAMA EĞİTİMİ NASIL YAPILIR?

Bu bölüm FR.185 madde 23 (haftada en az 15 kişiye kanser tarama eğitimi, eğitim planı ve en az 1 materyal) ve FR.186 madde 13 (her saha günü en az 1 kanser tarama eğitimi) için hazırlandı.

7.1 Hedef kişiyi doğru seçmek

Eğitimi kişinin yaşına ve gereksinimine göre şekillendirirsin:

- **30–39 yaş kadın:** Serviks taraması (HPV testi) + KKMM öğretimi.
- **40–49 yaş kadın:** Meme taraması (mamografi daveti) + KKMM + serviks taraması.
- **50–65 yaş kadın:** Meme + serviks + kolorektal (üç tarama birden; GGT kiti o gün verilebilir).
- **66–70 yaş kadın:** Meme (69 yaşa kadar) + kolorektal.
- **50–70 yaş erkek:** Kolorektal tarama (GGT kiti) + gerekirse sigara bırakma.
- **Genç kadın ve erkekler (hedef yaşın altındakiler):** KKMM / testis kendi muayenesi, HPV aşısı, kanserden korunma (sigara, beslenme, hareket), ailedeki hedef yaştaki bireyleri taramaya yönlendirme.

7.2 Eğitimin planlanması

Eğitim planında bulunması gerekenler: Konu, hedef kitle (yaş, cinsiyet, özellikleri), gereksinimin nasıl belirlendiği, yer, süre, genel amaç, ölçülebilir öğrenme hedefleri, içerik başlıkları, yöntem, materyal, eğitimin akışı, değerlendirme yöntemi ve sonucu.

Örnek eğitim planı – "Meme kanseri, KKMM ve ulusal meme taraması" (bireysel eğitim):

- **Hedef kitle:** ASM'ye başvuran 40–69 yaş kadın.
- **Gereksinim:** Kadın hiç KKMM yapmamış, son iki yılda mamografi çektirmemiş.
- **Süre:** 10–12 dakika.
- **Genel amaç:** Kadının meme kanseri taramasına katılmasını ve düzenli KKMM yapmasını sağlamak.
- **Öğrenme hedefleri (eğitim sonunda kadın):**
  - Meme kanserinin en az 3 risk faktörünü sayar. *(bilişsel)*
  - Meme kanserinin en az 4 uyarı belirtisini sayar. *(bilişsel)*
  - Ulusal meme taramasının yaş aralığını ve sıklığını söyler (40–69 yaş, 2 yılda bir mamografi). *(bilişsel)*
  - KKMM'yi ne zaman yapacağını söyler. *(bilişsel)*
  - Mamografi yaptırma niyetini ifade eder ya da randevu alır. *(duyuşsal)*
  - KKMM'yi meme maketi üzerinde doğru basamaklarla gösterir. *(psikomotor)*
- **İçerik:** Meme kanserinin önemi ve erken tanının yararı; risk faktörleri; uyarı belirtileri; ulusal program, KETEM, ücretsiz olması; KKMM'nin zamanı ve basamakları; bir değişiklik fark ederse ne yapacağı.
- **Yöntem:** Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma.
- **Materyal:** Meme maketi (en etkili materyal), resimli KKMM broşürü.
- **Değerlendirme:** Eğitim öncesi ve sonrası aynı 4–5 soru (ön test–son test), KKMM geri gösterimi (kontrol listesi), mamografi randevusunun alınıp alınmadığı.

Örnek ön test–son test soruları:

1. Meme kanseri taraması için mamografi hangi yaşlar arasında, ne sıklıkla çekilir?
2. Kendi kendine meme muayenesi ayın hangi günlerinde yapılır?

3. Meme kanserinin uyarı belirtilerinden üçünü söyleyebilir misiniz?
4. Meme kanseri için risk oluşturan üç durum söyleyebilir misiniz?
5. Memenizde bir değişiklik fark ederseniz ne yaparsınız?

KKMM geri gösterim kontrol listesi (her basamak doğru/yanlış olarak işaretlenir):

- Doğru zamanı söyledi (adet bitiminden 5–7 gün sonra / menopozda her ayın aynı günü).
- Ayna karşısında dört pozisyonu gösterdi.
- Bakarken nelere dikkat edeceğini söyledi.
- Yatar pozisyonu, omuz altına yastık ve kolu başın altına almayı gösterdi.
- Karşı elin üç parmağının iç yüzüyle küçük daireler çizdi.
- Üç basınç düzeyini uyguladı.
- Koltuk altı dahil tüm alanı sistemli bir düzenle (dikey şeritler) taradı.
- Bir değişiklik fark ederse nereye başvuracağını söyledi.

Örneğin kadın 8 basamağın 7'sini doğru yaptıysa sonucu "7/8 – yatar pozisyonda kolu başın altına almayı unuttu, tekrar gösterildi" şeklinde yazarsın.

7.3 Eğitimin uygulanması – örnek akış

Giriş (1–2 dakika): Kendini tanıt, izin al, dikkat çek ve gereksinimi belirle:

> "Merhaba, ben hemşirelik öğrencisi …. Size birkaç dakika meme sağlığı hakkında bilgi vermek istiyorum, uygun musunuz? Daha önce mamografi çektirdiniz mi? Kendi memelerinizi hiç muayene ettiniz mi?"

Gelişme (6–8 dakika): Kısa ve sade bilgi ver, sonra uygulamaya geç:

> "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser; ama erken yakalandığında tedavi başarısı çok yüksek. Bu yüzden 40 ile 69 yaş arasındaki her kadına iki yılda bir ücretsiz mamografi çekiliyor. Bunun yanında her ay kendi memenizi muayene etmeniz, bir değişiklik olursa erken fark etmenizi sağlar. Şimdi bu maket üzerinde size nasıl yapılacağını göstereyim…" Maket üzerinde göster; sonra kadından maket üzerinde ya da giyinik olarak kendi üzerinde pozisyonları göstermesini iste; hatalarını nazikçe düzelt.

Engelleri konuşma (1–2 dakika): "Mamografi çektirmeyi düşünür müsünüz? Sizi çekindiren bir şey var mı?" Korku, utanç, zaman, ulaşım, "bende belirti yok", "ailemde yok" gibi engelleri dinle ve yanıtla.

Sonuç (1–2 dakika): Özetle, sorularını yanıtla, son test sorularını sor, **eyleme dönüştür** ("İsterseniz şimdi KETEM'den randevunuzu alalım"), broşürü ver, teşekkür et.

7.4 Kişiyi taramaya ikna etmek: Sağlık İnanç Modeli ile düşünmek

İnsanlar taramaya şu durumlarda katılır: Kendini hastalığa **yatkın** görüyorsa, hastalığı **ciddi** buluyorsa, taramanın **yararının** engellerden fazla olduğuna inanıyorsa, onu harekete geçiren bir **uyaran** varsa ve testi **yapabileceğine güveniyorsa**. Eğitimde bu beş noktaya değinirsin:

- **Yatkınlık:** "Yaşınız 50 olduğu için bağırsak kanseri riskinin arttığı dönemdesiniz; belirti olmasa da tarama öneriliyor."
- **Ciddiyet:** "Geç kalındığında tedavisi zorlaşan bir hastalık."
- **Yarar:** "Erken bulunduğunda tedavi başarısı çok yüksek; hatta polip aşamasında yakalanırsa kanser hiç oluşmuyor."

- **Engelleri azaltma:** "Test ücretsiz, evde kendiniz yapabiliyorsunuz, birkaç dakikanızı alıyor; kiti şimdi verebilirim."
- **Harekete geçirici uyaran:** O anda kit vermek, randevuyu o anda almak, SMS hatırlatması.
- **Kendine güven (öz-etkililik):** Kişiye KKMM'yi ya da kit kullanımını uygulatarak "yapabilirim" duygusunu kazandırmak.

7.5 "Haftada en az 15 kişi" hedefini tutturmak

- **Bekleme salonunda kısa grup eğitimleri:** 3–6 kişilik gruplara 5–10 dakikalık eğitimler; günde 2–3 grup yaparsan haftalık hedefi rahatça geçersin.
- **Başka nedenle gelenleri değerlendirmek:** Tansiyon ölçümüne, reçeteye, bebek izlemine gelen ve hedef yaşta olan herkes bir eğitim fırsatıdır.
- **Her eğitimi aynı gün kaydetmek:** Tarih, kişinin baş harfleri, yaşı, cinsiyeti, konu, yöntem, materyal, değerlendirme sonucu (ön test–son test puanı, geri gösterim sonucu, kit/randevu durumu) ve izinli fotoğraf numarası.
- **Fotoğraf:** Kişinin **izni alınarak**, mümkünse yüzü görünmeden (maket, broşür, eller); kimlik bilgisi ve ekran görüntüsü olmadan.
- Plan bir kez hazırlanır; ama **değerlendirme her kişi için ayrı** yapılır.

7.6 Omaha ile kayıt (kısaca)

Kanser tarama eğitimleri Omaha sisteminde genellikle şöyle kaydedilir:

- **Problem:** Sağlıkla ilgili davranışlar alanı – **Sağlık bakımı denetimi**; kapsam **Birey** (grup eğitiminde **Toplum**); durum **Gerçek** (belirti: "rutin/koruyucu sağlık bakımını – kanser taramasını – yaptırmıyor") ya da kişi istekliyse **Sağlığın geliştirilmesi**.
- **Girişimler:** *Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık* – hedef: **Tarama işlemleri** (KKMM, mamografi, HPV testi, GGT), **Belirti/bulgular – fiziksel** (uyarı belirtileri); *Tedaviler ve işlemler* – hedef: **Örnek toplama** (GGT kiti, HPV örneği); *Vaka yönetimi* – hedef: **Diğer toplum kaynakları** (KETEM'e mamografi yönlendirmesi) ya da **Tıbbi bakım** (pozitif sonuçlunun kolonoskopi/kolposkopiye yönlendirilmesi); *Gözetim* – hedef: **Tarama işlemleri** (sonucun ve ileri incelemenin takibi, bir ay sonra KKMM yapıp yapmadığının sorulması).
- **Değerlendirme (1–5): Bilgi** ön test–son teste göre (ör. 2 → 4), **Davranış** taramaya katılım ve KKMM uygulamasına göre (ör. 1 → 3), **Durum** tarama durumuna göre (ör. taraması eksik 3 → randevu alındı/test yapıldı 4).

---

8. ÖRNEK CEVAPLAR ("Anlat" soruları)

8.1 "Bir kadına KKMM'yi nasıl öğretirsin?"

> "Önce kendimi tanıtıp izin alırım ve mahremiyeti sağlarım. Kadının yaşını, adet durumunu, daha önce KKMM ya da mamografi yaptırıp yaptırmadığını sorarım. KKMM'nin amacının kendi memesini tanımak ve değişikliği erken fark etmek olduğunu, mamografinin yerini tutmadığını anlatırım. Adet görüyorsa adet bittikten sonraki 5–7. günlerde, menopozdaysa her ayın aynı günü yapması gerektiğini söylerim. Meme maketi ve resimli broşürle önce ayna karşısındaki dört pozisyonu gösteririm: kollar yanda, kollar başın üstünde, eller belde kasılı, öne eğilerek; her pozisyonda şekil farkına, cilt çekintisine, portakal kabuğu görünümüne, meme başında çekilme ve akıntıya bakması gerektiğini anlatırım. Sonra yatar pozisyonu gösteririm: muayene edilecek tarafın omzu altına yastık, o taraftaki kol başın altında, karşı elin üç parmağının iç yüzüyle bozuk para büyüklüğünde daireler, her noktada hafif-orta-derin üç basınç, köprücük kemiğinden meme altı kıvrımına ve göğüs kemiğinden koltuk altına kadar dikey şeritlerle tarama; koltuk altını ve memenin üst-dış bölgesini atlamaması gerektiğini, kanserlerin en sık orada görüldüğünü söylerim. Kadına maket üzerinde uygulatırım, hatalarını düzeltirim, kontrol listesiyle değerlendiririm. Bir değişiklik fark ederse beklemeden başvurmasını, normal meme dokusunun biraz düğümlü olabileceğini anlatırım. 40–69 yaş arasındaysa mamografi için KETEM'e yönlendiririm. Ön test–son testle bilgisini değerlendirir, kaydeder ve bir ay sonra KKMM yapıp yapmadığını sorarım."

8.2 "55 yaşındaki bir erkeğe GGT kitini nasıl verirsin?"

> "Kendimi tanıtıp izin alırım. Daha önce bağırsak kanseri taraması yaptırıp yaptırmadığını, son testin tarihini sorarım. Dışkılama alışkanlığında değişiklik, makattan kanama, siyah dışkı, kilo kaybı, ailesinde bağırsak kanseri olup olmadığını sorarım; belirti varsa ya da ailesinde varsa kit yerine hekime yönlendiririm. Belirti yoksa 50–70 yaş arasındaki herkese iki yılda bir ücretsiz gaitada gizli kan testi yapıldığını, bağırsak kanserinin çoğunlukla poliplerden yıllar içinde geliştiğini ve erken yakalanınca önlenebildiğini anlatırım. Kiti göstererek kullanımını anlatırım: tüpe adını ve tarihi yazması, önce idrarını yapıp dışkının suya ve idrara karışmaması için klozete kâğıt ya da kap koyması, çubuğu dışkının birkaç yerine batırıp tüpe geri yerleştirmesi ve kapağı sıkıca kapatması, ellerini yıkaması, numuneyi serin bir yerde saklayıp en kısa sürede getirmesi. Bu testte diyet kısıtlaması gerekmediğini, ama hemoroid kanaması ya da idrarda kan varken numune almaması gerektiğini söylerim. Anlattıklarımı ona tekrar ettiririm, resimli talimatı veririm. Sonucun negatif çıkarsa iki yıl sonra tekrarlanacağını, pozitif çıkarsa bunun kanser demek olmadığını ama mutlaka kolonoskopi yapılması gerektiğini anlatırım. Kayıt eder, numunenin getirilip getirilmediğini ve sonucu takip ederim."

8.3 "HPV testine gelen kadına ne anlatırsın?"

> "Kendimi tanıtır, mahremiyeti sağlarım. Yaşını ve son tarama tarihini kontrol ederim; 30–65 yaş arasındaysa ve 5 yıl dolmuşsa taramanın hedefindedir. Hazırlık kurallarına uyup uymadığını sorarım: son 48 saatte cinsel ilişki, vajinal duş, tampon ya da vajinal ilaç kullanmamış olmalı, adet döneminde olmamalı. Rahim ağzı kanserinin neredeyse tamamının HPV adlı virüsten kaynaklandığını, bu virüsün çok yaygın olduğunu ve çoğu zaman kendiliğinden geçtiğini, testin amacının kanser olmadan önceki değişiklikleri yakalamak olduğunu anlatırım. İşlemin kısa sürdüğünü, genellikle ağrısız olduğunu, spekulumla rahim ağzının görülüp küçük bir fırçayla hücre örneği alınacağını, sonrasında hafif lekelenme olabileceğini anlatırım; derin nefes almasını, kaslarını gevşetmesini söylerim. İşlemde malzemeyi hazırlar, kadına destek olur, örneği hemen etiketler ve formu eksiksiz doldururum. Sonucu ne zaman ve nasıl öğreneceğini söylerim: HPV negatif çıkarsa 5 yıl sonra tekrar taranacağını; pozitif çıkarsa

> bunun kanser anlamına gelmediğini, ileri kontrol gerektiğini ve bu kontrolü kaçırmaması gerektiğini anlatırım. Ayrıca ilişki sonrası kanama, adet dışı kanama ya da kötü kokulu akıntı olursa tarama zamanını beklemeden başvurmasını söylerim. Sigara içiyorsa bırakmasını öneririm. Kayıt eder ve sonucu takip ederim."

---

9. KENDİNİ TEST ET

1. Tarama ile tanı arasındaki fark nedir? Memesinde kitle fark eden kadın taramaya mı yönlendirilir?
2. Birincil, ikincil ve üçüncül korunmaya kanserden birer örnek ver.
3. Bir kanser için tarama programı yapılabilmesi için hangi koşullar gerekir?
4. Türkiye'de ulusal taraması olan üç kanser hangisidir; hedef yaşlar ve sıklıklar nedir?
5. ASM'de kanser taramasında hemşirenin görevlerini say. Neden pozitif sonuç takibi bu kadar önemlidir?
6. 58 yaşında bir kadın tansiyon ölçümü için geldi. Hangi taramaları sorgularsın?
7. Meme kanserinin risk faktörlerinin çoğu hangi ortak mekanizmayla ilişkilidir? Beş risk faktörü say.
8. Meme kanserinin uyarı belirtileri nelerdir?
9. KKMM ne zaman yapılır? Menopozdaki kadın ne zaman yapmalıdır? Neden adet bittikten sonraki günler seçilir?
10. KKMM'de ayna karşısındaki dört pozisyon hangileridir?
11. Elle muayenede hangi parmaklar, kaç basınç düzeyi ve hangi patern kullanılır? Muayene alanının sınırları nelerdir?
12. Meme tümörleri en sık memenin hangi bölgesinde görülür?
13. Mamografi öncesi kadına hangi hazırlık önerilerini verirsin?
14. "Mamografi radyasyon veriyor, çektirmem" diyen kadına ne söylersin?
15. HPV ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkiyi anlat. Neden rahim ağzı kanseri "önlenebilir" bir kanserdir?
16. HPV-smear öncesi hazırlık talimatı nedir?
17. Örnek alma sırasında hemşirenin rolü nedir? Örnek neden hemen etiketlenmelidir?
18. HPV pozitif çıkan kadına ne söylersin?
19. Kolorektal kanserin risk faktörleri ve uyarı belirtileri nelerdir?
20. Tarama programında kullanılan gaitada gizli kan testinde neden diyet kısıtlaması gerekmez?
21. GGT kitinin kullanımını adım adım anlat. Hangi durumlarda numune alınmaz?
22. GGT pozitif çıkan kişiye ne söylersin ve ne yaparsın?
23. Testis kendi muayenesi kime, ne zaman, nasıl yapılır?
24. Benlerdeki değişiklikleri değerlendirmede ABCDE kuralı nedir?
25. Kanser tarama eğitimi için bilişsel, duyuşsal ve psikomotor birer hedef yaz.
26. Sağlık İnanç Modeli'ni kullanarak taramaya katılmayan bir kişiyi nasıl ikna edersin?
27. Bir kanser tarama eğitimini Omaha ile nasıl kaydedersin?